

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO SEVILLA DE CALIDAD DE VIDA (CSCV)

Eje IV: Calidad de Vida y Rehabilitación • Evaluación Específica en Trastornos Psicóticos y Esquizofrenia

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV).
Nombre Original	Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (Giner et al., 1997).
Autores Originales	J. Giner, E. Ibáñez, E. Baca, J. Bobes, C. Leal y S. Cervera (Grupo de Calidad de Vida en Psiquiatría).
Ámbito de Desarrollo	España (desarrollo multicéntrico en universidades y hospitales psiquiátricos españoles).
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida. Bienestar subjetivo en personas con esquizofrenia.
Tipo de Instrumento	Autoinforme específico de 59 reactivos con escala Likert de 5 puntos (0 a 4).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) diagnosticados de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o psicosis crónica.
Tiempo de Administración	15 a 25 minutos en administración supervisada o autoadministrada asistida.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación con citación de autores.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL PARADIGMA SUBJETIVO EN LA ESQUIZOFRENIA

El **CSCV** fue concebido para superar el sesgo historicista que relegaba al paciente psicótico a un mero objeto de observación conductual externa. El equipo de Giner y colaboradores (1997) demostró que las personas con esquizofrenia, en situación de estabilidad clínica razonable, son plenamente capaces de autoevaluar su bienestar interno con alta fiabilidad psicométrica:

- Estructura Bipolar Independiente:** El modelo demuestra que la calidad de vida en la psicosis se compone de dos dimensiones ortogonales: la presencia de **Aspectos Favorables** (recursos, satisfacción, energía y autonomía) y el impacto de los **Aspectos Desfavorables** (sufrimiento subjetivo, pérdida cognitiva, apatía y efecto iatrogénico de la medicación).
- Sensibilidad a Fármacos de Segunda Generación:** El instrumento fue validado para capturar la diferencia entre la mera sedación sintomática y la verdadera recuperación subjetiva y reintegración social.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (59 REACTIVOS)

El cuestionario consta de **12 subescalas** organizadas en dos macrodimensiones:

Macrodimensión / Escala	Nº Ítems	Subescalas Específicas Evaluadas en el CSCV
A. Aspectos Favorables	28 ítems	Tranquilidad, Vitalidad, Energía vital, Autoestima, Rendimiento y Relaciones sociales.
B. Aspectos Desfavorables	31 ítems	Pérdida de energía, Dependencia cognitiva, Dificultades afectivas, Inhibición, Sentimientos de incapacidad y Aislamiento.
Puntuación Total Neta	59 ítems	Balance integrador entre la vivencia de recursos personales y el peso de la patología.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

El estudio de validación multicéntrico español (Giner et al., 1997; $N = 412$ pacientes ambulatorios e institucionalizados) acredita una solidez métrica sobresaliente:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Aspectos Fav.	Alfa $\alpha = 0.92$	Altísima consistencia interna en la dimensión de recursos y bienestar subjetivo.
Consistencia Aspectos Desf.	Alfa $\alpha = 0.93$	Excelente fiabilidad en la medición de vivencias de incapacidad y sufrimiento.
Estabilidad Test-Retest	CCI $r = 0.82 - 0.88$	Estabilidad temporal confirmada en reevaluaciones a 2 semanas en pacientes estables.
Validez Factorial	2 Factores de orden superior	Análisis factorial confirma la ortogonalidad relativa de factores favorables y desfavorables.
Validez de Criterio	$r = 0.62$ (QLS)	Convergencia sólida con la Quality of Life Scale de Heinrichs-Hanlon-Carpenter.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Respuesta:** Escala Likert de 5 opciones: Nada (0), Poco (1), Regular (2), Bastante (3), Mucho (4).
- **Cálculo por Subescalas:** Se calcula la media de los ítems de cada una de las 12 subescalas (puntuaciones de 0.00 a 4.00).
- **Cálculo de Macrodimensiones:**
- **Dimensión Favorable (AF):** Suma de los 28 reactivos favorables (rango 0 a 112 puntos).
- **Dimensión Desfavorable (AD):** Suma de los 31 reactivos desfavorables (rango 0 a 124 puntos).
- **Índice Global de Calidad de Vida (Puntuación Estandarizada 0-100):** Para facilitar la interpretación clínica, se transforman las puntuaciones netas en una escala porcentual donde puntuaciones más altas indican **mayor bienestar subjetivo y calidad de vida**.

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA EN PACIENTES PSICÓTICOS

Estratificación	Escala 0-100	Nivel Subjetivo	Estado de Recuperación Psicosocial y Bienestar
Favorable / Alto	75 a 100 pts	Buena calidad de vida	Vínculos preservados, autonomía activa y buena tolerancia a antipsicóticos.
Moderado / Típico	50 a 74 pts	Calidad de vida media	Estabilidad clínica con síntomas negativos residuales leves; autonomía parcial.
Insatisfactorio	35 a 49 pts	Calidad de vida deficiente	Sentimientos frecuentes de incapacidad, anhedonia reactiva y retraimiento.
Severo Malestar	< 35 pts	Colapso de calidad de vida	Sufrimiento psíquico extremo, sobrecarga sedativa o depresión postpsicótica.

SIGNIFICACIÓN DE ELEVADOS ASPECTOS DESFAVORABLES (> 80 PTS):

Puntuaciones desfavorables elevadas (> 80 puntos directos en AD) son el marcador psicométrico más específico de depresión postpsicótica sobreimpuesta o impregnación neuroléptica excesiva (síndrome deficitario inducido por fármacos), requiriendo ajuste de dosis.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y AJUSTE TERAPÉUTICO

PROTOCOLO DE MONITORIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN LA ESQUIZOFRENIA:

- **Paso 1 (Administración en Fase Estable):** Aplicar el CSCV cuando los síntomas psicóticos positivos agudos hayan remitido (PANSS positiva < 18).
- **Paso 2 (Análisis del Patrón AF vs. AD):**
 - Si AD es muy alto pero AF es moderado: El paciente sufre pero conserva esperanza y metas; priorizar ajuste farmacológico para reducir temblores, acatisia y rigidez.
 - Si AF es muy bajo (< 25): Prescribir programas comunitarios de ocio guiado y rehabilitación vocacional estructurada.
- **Paso 3 (Intervención en Dependencia Cognitiva):** Si la subescala de Dependencia Cognitiva es elevada, pautar entrenamiento en remediación cognitiva individualizada (REHACOP).
- **Paso 4 (Evaluación Evolutiva):** Reevaluar cada 6 meses para objetivar la restitución del proyecto vital del consultante.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: CAMBIO DE ANTIPSICÓTICO Y REHABILITACIÓN VOCACIONAL

Identificación: Varón de 31 años diagnosticado de esquizofrenia paranoide de 6 años de evolución, en remisión de ideas delirantes pero con severo aislamiento en casa, quejas de embotamiento afectivo y aumento de 18 kg bajo tratamiento con haloperidol y biperideno.

Evaluación Psicométrica Inicial CSCV:

- **Aspectos Favorables = 24 / 112 pts (Muy Bajos);** Vitalidad = 0.5/4; Relaciones sociales = 0.4/4).
- **Aspectos Desfavorables = 94 / 124 pts (Severamente Elevados);** Pérdida de energía = 3.8/4; Sentimientos de incapacidad = 3.5/4).
- **Índice Global CSCV = 28 / 100 puntos (Calidad de Vida Crítica).**

Intervención Interdisciplinar: Psiquiatría realizó switch progresivo a un antipsicótico atípico con perfil metabólico favorable y agonismo parcial dopamínérgico (Aripiprazol). El equipo psicosocial lo integró en un Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) y en un taller de actividad física comunitaria.

Reevaluación a los 8 Meses: Los Aspectos Desfavorables se redujeron a **42 / 124 pts** y los Aspectos Favorables se incrementaron a **71 / 112 pts**, elevando el índice global a **66 / 100 puntos**. El paciente comenzó prácticas laborales remuneradas en jardinería, expresando satisfacción subjetiva con su nueva vida.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO SUICIDA POSTPSICÓTICO:

Una caída abrupta en Aspectos Favorables con toma de conciencia de la enfermedad (insight elevado) aumenta drásticamente el riesgo de suicidio en personas con esquizofrenia.

INFLUENCIA DE SÍNTOMAS POSITIVOS:

En pacientes con delirios místicos o megalomaniacos no controlados, los Aspectos Favorables pueden inflarse artificialmente; interpretar siempre en situación de estabilidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Giner, J., Ibáñez, E., Baca, E., Bobes, J., Leal, C., & Cervera, S. (1997). Desarrollo del Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV). *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*, 25(Supl. 2), 11-23.
2. Bobes, J., et al. (1998). Propiedades psicométricas del Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida en pacientes esquizofrénicos. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 25(4), 95-104.
3. Giner, J., et al. (2001). Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida: Versión abreviada y validación transcultural. *Psiquiatría Biológica*, 8(3), 87-94.
4. Baca, E., et al. (2003). Subjetividad y calidad de vida en la esquizofrenia: La perspectiva del paciente. *Archivos de Psiquiatría*, 66(1), 35-48.